

Université de Constantine 3- Faculté de médecine
Centre Hospitalo-universitaire de Constantine Dr Benbadis
Service de Médecine Interne

Sémiologie pondérale :

Cours de sémiologie:

Etudiants de 3ème année médecine

Dr Kermiche.M
Année 2024/ 2025

Plan du cours:

1. Introduction

2. Poids normal :

- Chez l'enfant*
- Chez l'adulte*

3. Poids pathologiques :

- Excès de poids :
 - => L'obésité*
 - => L'oedème**
- Pertes de poids :
 - => L'amaigrissement*
 - => Les déshydratations**

1. Introduction :

Le corps comprend 4 secteurs principaux :



Ces secteurs sont entre eux en proportions définies, dont la somme représente le poids corporel global.

Le poids corporel d'un individu normal adulte est stable à 1 – 2 kg près.

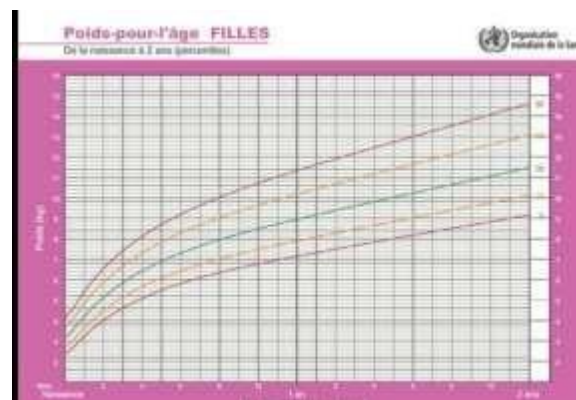
Des variations portant sur chacun de ces secteurs peuvent modifier le poids corporel

2. Le poids normal :

Le poids normal (poids idéal) est déterminé par rapport à la taille ; il est également fonction de l'âge, du sexe et de la corpulence (statut osseux).

- Chez le nourrisson et l'enfant :

Il existe des courbes de poids établies en fonction de la taille et de l'âge.



Un nouveau-né à terme pèse 3,5 kg et mesure 50 cm; approximativement il double son poids de naissance à 5 mois, il le triple à 1 an.

- Chez l'adulte :

Le poids normal peut être déterminé de plusieurs manières.

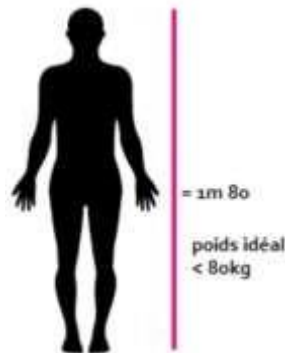
1. La formule de Lorentz :

$$\text{Poids} = (\text{taille (cm)} - 100) - \frac{\text{Taille} - 150}{4(\text{Homme}) \text{ ou } 2(\text{Femme})} \text{ kg}$$

Remarque : Il faut ajouter 1 – 2 kg per décennie au delà de 20 ans.

2. Mesure du poids à partir de la taille :

Le poids idéal correspond au nombre de centimètres au-dessus du mètre.



3. L'indice de masse corporelle (IMC ou BMI) :

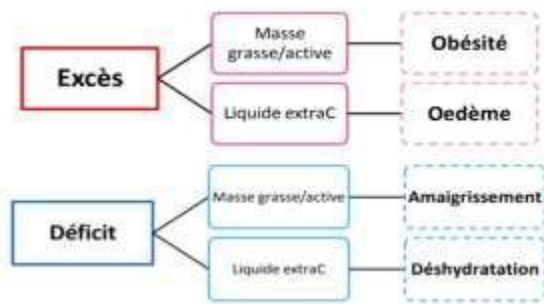
$$\text{IMC} = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Taille}^2 (\text{m})} \text{ kg/m}^2$$

IMC	signification
< 14,5	Cachexie.
< 18,5	Amaigrissement (insuffisance pondérale).
[18,5 - 24,9]	Poids normal.
[25 - 29,9]	Surpoids.
[30 - 34,9]	Obésité modérée.
[35 - 40]	Obésité sévère.
> 40	Obésité morbide.

4. Tour de taille (circonférence de taille) :

Il est mesuré avec un mètre ruban à mi-distance entre le rebord costal et l'épine iliaque antéro-supérieure sur la ligne médio-axillaire, à la fin d'une expiration normale et sans exercer de pression sur la peau. Normal : Femme : < 88 cm, Homme : < 102 cm

3. Les poids pathologiques :



A. Les excès de poids :

1. L'obésité :

L'obésité se définit par une augmentation du poids en rapport à une augmentation de la masse grasseuse : au-delà de 20 % du poids normal

Etude sémiologique :

L'interrogatoire :

Les modalités de la prise de poids :

- l'âge de début (poids de naissance, lors des visites médicales scolaires...)

photos, tailles vestimentaires successives.

prise pondérale a été progressive ou rapide.

b) Les circonstances déclenchantes :

- choc émotionnel ou affectif (puberté, contraception, ménopause, grossesse);
- réduction de l'activité physique;
- sevrage de tabac;
- traitement par les dérivés cortisones, les antidépresseurs, les neuroleptiques.

c) Le comportement alimentaire: troubles quantitatifs ou qualitatifs.

— Les troubles quantitatifs : 20 % des cas; ils réalisent la polyphagie : le malade mange beaucoup par élévation du seuil de la satiété.

Les troubles qualitatifs : fréquents, 2/3 des cas. :

- La compulsion alimentaire : impulsion soudaine à consommer un aliment donné, glucidique++.
- Le grignotage : le sujet mange sans arrêt de petites quantités.
- La boulimie : c'est en dehors de toute faim l'ingestion de grandes quantités d'aliments de toute sorte; elle évolue par crises

d) Les dépenses énergétiques : – le métabolisme de base

– la thermo-régulation

– le travail intrinsèque (mental, digestif, cardiaque, etc ...)

e) L'enquête psychologique : qui permet de déterminer le profil psychologique.

J) Les antécédents familiaux : 8 fois sur 10 on retrouve une obésité chez l'un des parents.

L'examen clinique : il se fixe 4 objectifs :

=> Apprécier le degré de la surcharge pondérale :

Prise de poids (pèse-personne ou balance)

- La pesée : ✓Tables des poids (enfants++)
✓Taille/ poids
- La formule de Lorenz
- IMC (BMC)
- Périmètre abdominal

En fonction de la surcharge pondérale, on distingue :

Obésité modérée : excès de poids de 20 – 50 %

Obésité sévère : excès de poids de 50 à 100 %

Etude du pannicule adipeux (adipomètre) : C'est l'appréciation du pannicule adipeux :

-manuellement apprécier l'épaisseur de la couche de graisse au niveau de la peau

- utilisation d'un adipomètre (appréciation plus objective)



=> Déterminer le type d'obésité :



obésité mixte



obésité cushingoïde



Obésité mixte : obésité globale.

Obésité cushingoïde : obésité facio-tronculaire.

=> Rechercher les signes accompagnateur :

Les vergetures : ce sont des stries plus ou moins longues et plus ou moins larges ; blanchâtres ou rougeâtres siégeant au niveau de l'abdomen, des cuisses, parfois des seins.

Elles correspondent à la rupture des fibres élastiques du derme. Elles se voient dans les obésités de constitution rapide et sont particulièrement nombreuses dans l'obésité cushingoïde.

La cellulite : qui est un épaissement de la peau qui prend l'aspect de peau d'orange ; elle siège essentiellement au niveau des hanches et des cuisses.

=> Dépister des complications :

Mécaniques : arthrose des hanches et des genoux, troubles de la statique vertébrale.

Respiratoires : insuffisance respiratoire chronique pouvant réaliser un syndrome de Pickwick.

Métaboliques : diabète, athérosclérose, goutte et hyperlipidémie.

c. Causes des obésités :

Les renseignements fournis par l'anamnèse et l'examen permettent d'orienter vers le diagnostic

1°- Obésité essentielle : Pas de cause évidente (obésité familiale, idiopathique, primitive)

2°- Obésités secondaires :

- Psychogène (boulimie)
- endocrinienne (Hypercorticisme, myxœdème,
- médicamenteuse (neuroleptiques, pilule, corticoïdes)
- neurologique (pathologie des centres régulateurs de la faim, de la satiété)

2. Les œdèmes :

a. Définition :

• Les oedèmes réalisent une infiltration sous-cutanée en rapport avec une rétention hydrique, qui va entraîner un excès de poids aux dépens du secteur liquidien extracellulaire.

b. Etude sémiologique :

L'examen clinique :

Va permettre de reconnaître les œdèmes.

☐ Leur siège :

Ils peuvent être :

- Localisés :

• Régions déclives : sujet debout, région malléolaire (chevilles) et jambes (le long de la face interne du tibia). Sujet couché : région lombaire et face interne des cuisses

• Régions où le tissu cellulaire est le plus lâche : paupières et dos des mains.

- Généralisés :

• Tous les tissus cellulaires sous-cutanés, ils sont bilatéraux et symétriques.

☐ Leur aspect :

Les œdèmes se traduisent par :

- A l'inspection : une augmentation du volume de la région, la peau est lisse, luisante, avec effacement des saillies et des méplats.

- A la palpation : le signe du godet : la pression du doigt laisse une empreinte sur la peau.

L'aspect des œdèmes va varier en fonction de leur cause et de leur ancienneté :

- Rénale : blancs, mous, indolores, gardent bien le godet,

- Cardiaque : de couleurs rosés ou rouges violacés, fermes et douloureux, prennent mal le godet.

- Récents : Mous, gardent bien le godet.

- Anciens : Fermes et douloureux.

Les pertes de poids :

A- Amaigrissement :

Définition :

C'est une perte (ou chute) du poids normal en rapport avec :

– masse musculaire

– masse adipeuse

Remarque : +++ Différence entre un :

- Amaigrissement : Chute secondaire du poids du poids

- Etat de maigreur : o État physiologique

o Depuis le jeune âge

Etude sémiologique :

Elle repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique.

. L'interrogatoire : recherche :

- La rapidité et l'importance quantitative de la perte de poids

- La valeur sémiologique de l'amaigrissement est d'autant plus grande que celui-ci est plus massif et plus rapide (quelques semaines.)

- Un symptôme associé important

L'anorexie (inappétence) : qui peut être responsable de l'amaigrissement (mais qui peut manquer).

D'autres signes associés : troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée et asthénie.

. L'examen clinique :

- Pannicule adipeux

En cas d'amaigrissement important, la peau est flasque et paraît trop grande pour le corps, surtout visible au niveau des bras, des cuisses et de l'abdomen.

Appréciation de la masse musculaire : au niveau des bras et des mollets.

B- Déshydratations :

Définition :

- diminution souvent brutale du secteur liquidien extracellulaire. Parfois associés à une diminution du secteur liquidien intracellulaire.

Déshydratation extracellulaire

- ❑ perte d'élasticité normale : elle garde le pli.
- ❑ Hypotonie des globes oculaires (yeux cernés, enfoncés).
- ❑ Hypotension artérielle et tachycardie.
- ❑ Oligurie.
- ❑ Perte de poids.

Déshydratation intracellulaire

- ❑ Soif intense.
- ❑ Sécheresse des muqueuses (se recherche au niveau de la muqueuse jugale).
- ❑ Polypnée, fièvre centrale (non infectieuse).
- ❑ Troubles de la conscience.
- ❑ Perte de poids importante.

Déshydratation globale

L'on retrouve des signes de déshydratation extracellulaire et intracellulaire. Elle se voit en cas de **pertes digestives importantes**.

Références :

Rose-Marie Hamladji, Précis de Sémiologie, en ligne depuis :

<https://www.sofiotheque.info/2016/09/precis-de-semiologie-rose-marie.html>